

| Krankheit                  | Anamnese/Symptome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Status                                                                                                                                                                                                                                                                     | Untersuchungen/ Abklärungen                                                                                                                                                          | Therapie                                                                                                                                                                                          | Kommentar                                                                                                                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MUND</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| Schmeckstörung             | <u>Hypoguesie, Aguesie, Paraguesie, Phantoguesie</u><br><br><u>Trigger:</u> Infekte, Hygiene, Alter, Psyche, Medis (Antimykotika), Mangelernährung, Neurologie, Chemo- und Radio-Tx etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Zunge + Mund inspizieren + palpieren</b> , Sulcus amygdalogl., <b>Motorik Zunge</b> (Hypoglossus) <b>Neurostatus:</b> Trigemini testen (Sens., Sz., Kalt-Warm + Dermatome), Fazialis (Geschmack Ch. tympani + restl. Funktionen Fazialis), Glossopharyngeus (Geschmack) | <b>Geschmack testen</b> (Tast strips, + Geruch testen, Pat. verwechseln beides oft) <b>Labor</b><br><br><b>Ev. MRI/CT</b>                                                            | <b>Je nach Ursache:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Medi/Noxen-Stopp, Spontanerholung abwarten</b></li> <li>- <b>Zink</b></li> <li>- <b>meist keine Kausaltherapie</b></li> </ul> |                                                                                                                                                             |
| Mukosa-Veränderungen (Mix) | <p><b>Angina-Plaut-Vincenti:</b> Spirochäten + Fusobakterien &gt;Odynophagie &gt;i.d.R. einseitig fibrinbedecktes Ulkus auf Tonsille &gt;Gram-Präp &gt;<b>Mundflege</b> + ev. <b>Verätzung, AB</b> (falls s. stark)</p> <p><b>Diphtherie:</b> Corynebakt. Diphtheriae &gt;Fieber, Schluck-Sz, LK &gt;weissl. Beläge auf Tonsille/Uvula/Gaumensegel/Larynx, Azetongeruch &gt;Abstrich + Kultur &gt;<b>Antiserum</b> + <b>Augmentin, Gurgeln</b></p> <p><b>Mononukleose/Pfeiff. Drüsenfieber:</b> EBV &gt; AZ red., Fieber, Kopf- + Glieder-Sz., Bauch-sz., kein Appetit, Schwellung Waldeyerring, LK, Systemerkrankung (Leber!) &gt;Tonsillen hochrot + geschwollen, gelbl-grau-schleimige konflu. Beläge/Strassen&gt;BE (atyp. LZ, mononukl. Zellen, Leberwerte, Serologie erst im Verlauf &gt;IgM), US (Leber + Milz), EKG &gt;<b>sympt. NSAID (kein Aspirin)</b>, Superinf. <b>AB</b> (KEIN Penicillin! &gt;Exanthem), Bettruhe, kein Sport 6 Wo., Fluesssigkeit!</p> <p><b>Herpangina:</b> Cocksackie-Viren &gt;hoch Fieber, Hals/Kopf-Sz, Dysphagie &gt;viele kl. sz.hafte Bläschen (roter Hof) am Gaumenbogen/Uvula/Tonsillen &gt;symptomatisch (<b>Gurgeln</b> mit <b>Aspegic</b>, bei Kindern KI!!!)</p> <p><b>Stomatitis herpetica:</b> HSV &gt;Sz., Brennen, Fieber &gt;Bläschen + Aphten an Lippen + Mukosa &gt;Abstrich + Serologie &gt;<b>symptomatisch, AB</b> bei Superinf., <b>Acyclovir</b> falls Komplik. (Encephal.)</p> <p><b>Angina granulotica necroticans:</b> multiple Bakterien &gt;sept. Bild, Ulkus + Nekrosen, Foetor, keine LK! &gt;BE (Agranulozytose) &gt;<b>AB, B-Transfusion, Gurgeln</b></p> <p><b>Candida-Mykose/Soor-Stomatitis:</b> fest-haftende bei Entf. blutende weisse Beläge, gerötete Mukosa &gt;Abstrich&gt;<b>top. Antimykotika, Lutschtabletten, Fluconazol syst.</b> (wenn larynx/Ö.)</p> <p><b>Herpes simplex labialis:</b> HSV-I, Bläschen (auch enoral möglich) + ev. Krusten an Lippe &gt;diverse Symptome, meist guter AZ &gt;klin. Dx. &gt;<b>Desinfektion, Zovirax</b> (Aciclovir)-Salbe od. syst.</p> <p><b>Perlèche/Faulecken:</b> Eorsionen Lippenwinkel, ev. Krusten &gt;Ursache: Speichelfluss, Prothesen, DM, Vit./Fe--Mangel, AB, Allergie, Lecken &gt;<b>Grunderkrankung, Hautschutz</b></p> <p><b>Herpes Zoster:</b> VZV, gruppierte sz-hafte Bläschen, Ulzera+Krusten&gt;Abstrich (PCR: Erregernachweis) &gt;<b>Aciclovir</b> syst., <b>NSAID, Carbamazepin</b> (gg. Neuralgie), <b>lokale AB</b>, ev. <b>top. St.</b></p> <p><b>Habituelle Apften:</b> flach-ulzeröse Läsionen mit rotem Hof &gt;<b>Mundspülungen</b> (Aspegic), <b>Tinktur, Steroid-Gel, Thalidomid/Contergan</b> falls s. schwer</p> <p><b>Blick-Dx:</b> Lingua plicata (Melkersson-Rosenthal-Syndrom), <b>schwarze Haarzunge</b> (nach AB, Steroide etc.), <b>L. geographica</b> (normal, kann bei Psoriasis auftreten), <b>Glossitis rhombica</b>, <b>Zungengrundstruma</b>, <b>Mundwinkelrhagaden</b> (Vitaminmangel), <b>Gingivitis/Peridontitis</b>, <b>Hypertrophe Hydrantoistomatitis</b>, <b>Fordyce-Anomalie</b>, <b>Ranula</b> (Retentionszyste), <b>Leukoplakie</b>, <b>Erythroplakie/M. Bowen</b>, <b>Orale Haar-Zell-L</b> (Präkanzerose), <b>Soor-Stomatitis</b>, <b>Herpes</b>, <b>Hunter Glossitis</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |
| Fremdkörperaspiration      | Was aspiriert? Prothese?<br>Husten, Schleim, Zyanose, Stridor, Dyspnoe, Sz., Speichelfluss, FK-Gefühl, Dysphagie, Odynophagie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1. Inspektion</b> (Zyanose, Speichelfluss, Mund/Rachen, ev. Laryngoskopie)<br><b>2. Auskultation</b>                                                                                                                                                                    | <b>Rx-Thorax</b> + Halsweichteile (Gastrographinbreischluck falls V.a. auf FK im Ö.)<br><b>Pneumologen + Anästhesie</b> (Intub. falls starre E.) informieren<br><b>PVK legen, O2</b> | <b>1. Endoskopie* bzw. Bronchoskopie</b><br><b>2. Falls drohende Asphyxie: Heimlich-Manöver</b><br><b>3. Cortison, AB ev.</b>                                                                     | *zuerst flexibel >weicher FK wird in Magen gestossen, sonst mit dann mit starrer E. rausgefischt<br><br>FK in Nase mit Häckchen entfernen (ev. LA/Sedation) |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ingestion</b> (orale Einnahme tox. Stoffe) | Dysphagie, Odynophagie, Dyspnoe, Dyphonie                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1. <b>Inspektion</b> (Zyanose, Mund-Rachen, ev. Laryngoskopie)                                                                                                           | 1. <b>PVK</b> legen<br>2. <b>Endoskopie</b>                                                                                                                                                  | 1. <b>Steroide</b> (hochdosiert)<br>2. <b>Flüssigkeit</b> i.v.<br>3. <b>AB</b> (Breiband)                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| <b>Akute Atemnot</b>                          | Atemnot, ev. Zyanose<br><br>Fragen: FK, Beinschmerz, Panikattacke,                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. Pat. <b>beruhigen, O2</b><br>2. <b>Inspektion</b><br>3. <b>Anästhesie</b> rufen<br>4. Je nach Dringlichkeit <b>untersuchen od. direkt Intubieren</b>                  | > <b>O2</b> geben, <b>PVK</b><br>1. <b>Adrenalin</b> (inhalat., s.c.)<br>2. <b>Antihistaminikum</b><br>3. <b>Cortison</b><br>4. <b>Atemweg sichern</b> (Intub., Koniotomie od. Tracheotomie) | <b>Ursache finden</b> + behandeln:<br><br><b>BE</b> (D-Dimere u.a.)<br><b>Rx-Thorax</b>                                                                                                                                                                                                | I.d.R. macht man Tracheotomie (Konio s. selten)                                                                                                  |
| <b>Quincke-Ödem</b>                           | akutes Oedem d. tieferen BG v. Lippe od. Augenlider od. Zunge od. Rachen, Atemnot, Zyanose                                                                                                                                                                                                                                                            | Atemweg sichern! PVK legen, Anästhesie rufen                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              | <b>Adrenalin, Cortison, Anthihist.</b> , ev. <b>Intubation</b> , Noxen weg, bei C1-Estares-Mangel Gabe v. <b>C1-Estares-Konz.</b>                                                                                                                                                      | Ursachen: Histaminvermittelt (idop., ASS-Intol, ACE-H., allergisch/IgE, etc.) od. C1-Esterase-Mangel                                             |
| <b>Stottern</b>                               | Wie war Entwicklung d. Kindes, Kindheit, psycho-soz. Umfeld (Erwartungen, Disziplin, wenig Geduld, Kritik), <u>Wiederholungen</u> , <u>Dehnungen</u> , <u>Blockierungen</u> , <u>Begleitphänomen</u> (z.B. auf Seite schauen od. Augen schliessen, lautere und höhere Stimme), in gew. Situationen symptomfrei (Speilen mit Puppen, Zählen, etc.), FA | <b>Kind</b> (Sprache, Spielverhalten, Gefühlsausdruck) + <b>Eltern kennenlernen</b><br><br><b>Übers Stottern sprechen</b><br><br><b>HNO-Status</b><br><br><b>Hörtest</b> | Entwicklungsprofil, Sprachverständnis, Artikulation, Freispiel, Kommunikation mit Therapeut, Audit. + visuelle Wahrnehmung                                                                   | <b>Psychologie: Modifikation Stottern</b> (Ängste, Vermeideverhalten + Anspannung abbauen)<br><br><b>Spiel- + Sprechtherapie: Logopädie</b> >Flüssiges Sprechen<br><br>Wichtig: Eltern miteinbeziehen, ev. Psychotherapie                                                              |                                                                                                                                                  |
| <b>Lippen-Kiefer-Gaumenspalte</b>             | Trinken/Saugen erschwert, Übertritt v. Nahrung in Nase, offenes Naseln (Hyperrhinophonie), Palatolalie + -phonie, Ruckverlagerung Zunge, harte Stimmeinsätze, Verschlusslaute schwach (b, p, g, k), oft Tubenfunktionsstörung mit Hörverlust                                                                                                          | <b>Inspektion Mund- + Rachen Nase</b><br><b>Gehör</b> (Seromukotympanon, Cholesteatom)<br>>Schalleitungsschwerhörigkeit)                                                 | <b>Dx Nasalität:</b> nasaler Airflow messen, Pusten/Blasen, Palpation, etc., nasale Endoskopie, Nasometrie<br><br><b>Bildgebung (CT)</b>                                                     | <b>Saugen/Trinken:</b> Trinkplatte, Flaschensauger, Löffelschoppen<br><br><b>Gehör:</b> Parazentese, Paukenröhrchendrainage<br><br><b>Chirurgie:</b> Verschluss Lippen, dann Weichgaumen, Später Hardgaumen<br><br><b>Logopädie</b> (Artikulation, Luftstrom) + ev. <b>Psychologie</b> | <u>Formen:</u> Lippenkerbe od. -spalte, Lippen-Kiefer-Spalte, Uvula bifida, submukose Spalte, hintere Gaumenspalte, Lippenkiefergaumenspalte LKG |

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Tumoren Mundhöhle</b> (Zunge, Lippen, Gaumen, Mundboden, etc.)</p> | <p>RF: Rauchen, Alk, Präkanzerosen (L. planus, Erythro- + Leukoplakie, HPV, etc.), aktinische Keratose/UV, Luftverschmutzung, +FA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Untersuchung Mund</b> (sehr gut auch <b>Sulcus amygdalaglossus und Mundboden</b>) + <b>Rachen Lymphknoten</b></p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Panendoskopie mit Biopsien</b> <b>FNP</b> (Zytologie), <b>Biopsie</b> <b>US, CT</b> (Knochen, Larynx), <b>MRI</b> (Weichteile), <b>PET-CT</b>(Staging v.a.)</p>              | <p><u>PE-Ca Mundboden</u>: <b>Teilresektion Mundboden</b> + bds. <b>Neckdissection</b>, <b>Mundbodenrekonstruktion</b><br/> <u>PE-Ca Zungen-Ca</u>: <b>minimale Chirurg.</b> (falls keine Metast.)<br/> <u>PE-Ca-Zungengrund</u>: <b>RT-Chemo</b></p> <p><u>Leukoplakie, Erythroplakie, Condyloma</u>: <b>Exzision + Biopsie</b><br/> <u>Candida</u>: <b>top. Antimykotika</b><br/> <u>Lichen planus</u>: <b>top. Steroide</b><br/> <u>Orale Haar-Zell-Leukoplakie</u>: <b>Vit.A-Säure, Podophyllin</b><br/> <u>Mucormycosis</u>: radikales <b>Debridement, syst. Antimykotika</b></p>                                                                                                                      | <p><b>90% PE-Ca!</b></p> <p><b>DD</b>: Candida-Mykose, <b>Leukoplakie</b>, Fordyce-Anomalie, <b>Lichen planus</b>, orale Haarzell-Leukoplakie, Lingua geografica, Haarzunge, <b>Erythroplakie</b>, Hämangiom, Lymphangiom, Pyogenes granulom, HSV, M. Wegener, <b>Mukormycosis, Condyloma acuminata</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Kiefergelenkserkrankung</b></p>                                    | <p>Kiefergelenksknacken, Sz., (beim Kaufen), Muskel-Sz., Trismus, Ohren-Sz., Schwellung, Zähneknirschen, Zahn-Sz., Systemerkrankungen (RA, &gt;Morgensteifigkeit, Schwellung, Rheumaknoten, Deformation, etc.), Fieber (infekt. Arthritis), Dysphagie, Atemnot</p> <p><u>Hinweise f. Tumor</u>: spontane Okklusionsstörung, Mittellinienabweichung v. UK bei Mundöffnung</p> <p><u>RF</u>: Alter, Prothese, Mangelernährung, Infekte, Osteoporose, chron. Reize, Zahnverlust, Karies/Hygiene</p> <p><u>RED FLAGS</u>: Trismus, Atemnot, F. canina Abszess, Dysphagie, CRP&gt;100</p> | <p><b>Inspektion UK + OK</b> (Symmetrie, Dysgnathie, Kammatrophy, Schwellung, Rötung), <b>passive + aktive Beweglichkeit</b> testen, <b>Gelenk palpieren</b>, <b>Mundöffnung messen</b>, <b>Knacken hörbar? Trismus?</b> <b>Mund + Rachen inspizieren</b>, <b>Zähne</b> (E., Abszess, ), <b>Alveolarkämme</b> (Dicke/Atrophie), <b>Lymphknoten</b></p>             | <p><b>Labor (CRP, LK), US, CT (bei Logenabszess v.a.!), Zahn-Rx</b></p> <p>*falls kein Fieber, kein Trismus, akute Zahn-Sz., kein Eiterausstritt &gt;keine AB sondern abwarten</p> | <p><u>Bruxismus</u>: Stressabbau, Physio, Okklusionsschiene<br/> <u>Diskopathie</u>: Physio, Arthroskopie + Lavage, Hyaluronsäure<br/> Diskettomie/Arthroplastik<br/> <u>Arthrose</u>: NSAID, Steroide, Arthroplastik, Resektion<br/> Ankylosemasse (bei Ankylose)<br/> Synoviale Chondromatose:<br/> Arthrotomie, Entfernung<br/> Gelenkskörper, Resektion Synovia<br/> <u>Tumor</u>: je nach Typ<br/> Dentogene Infektion: AB*, Drainage (Abszess) &gt;Abstrich, Spülung, Zahnbehandlung<br/> <u>Kieferkammatrophy</u>: Implantate, Hygiene, Knochenaufbau<br/> <u>Dysgnathie</u>: Chirurgie (bilat. sag. Schnitt od. Le-Fort-Osteotomie od. Mandibulo-maxill. Osteotomie), Genioplastik (Weichteile)</p> | <p><b>Bruxismus</b>: Zähneknirschen<br/> <b>Diskopathie</b>: Luxation, Diskusverlagerung &gt;Knacken,,<br/> <b>Arthrose</b>: Sz., z.T. Trismus, im Extremfall Ankylose mit Trismus<br/> <b>Arthritis</b>: i.R. RA od. Psoriasis z.B., infektiös, reaktiv od. postinfektiös<br/> <b>Tumor</b>: <b>Synoviale Chondromatose, Osteochondrom, Sarkom</b><br/> <b>Dentogene Infektion</b>: submukoöser Abszess, Fossa canina-Abszess, Logenabszess<br/> <b>Kieferkammatrophy</b>: Reduktion Gesichtshöhe weil Atrophie/ Degeneration UK/OK<br/> <b>Dysgnathie</b>: Kieferfehlstellungen &gt;Pro- + Retrognathie d. UK/OK, falls 6er-Zahn des OK nicht auf Höhe des 1. Molaren des UK zu liegen kommt bei Neutralbiss.</p> |
| <p><b>Periphere Fazialisparese</b></p>                                   | <p>Trockenes Auge, Sz. Auge, Geschmacksverlust, keine Tränen mehr, Hypakusis, Probleme mit Mundschluss/Essen</p> <p><u>RF</u>: Infekt (Ohr, obere Atemwege), Trauma, Schwellung Parotis (Tumor)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Inspektion</b> (Bell-Phänomen/Parese, Ptose, Nasolabialfalte)<br/> <b>Auge</b> (Schirmertest, Spalt, Auflicht/Fluoreszin)<br/> <b>Gehör</b> (Hörtest, Stimmgabeln, Otoskopie, Stapediusreflex!)<br/> <b>Mund</b> (Mundschluss, Fazialistest, Geschmack testen)<br/> <b>Neurostatus</b>: Fazialistesten (periphere vs. zentrale Parese), Geschmack, Gehör</p> | <p><b>BE, Serologien</b> (Borreliose, HSV, HIV, , ev. LP</p> <p>Falls Persistenz &gt;3Mte &gt;<b>MRI</b> (Abklärung Parotis-Tumor)</p>                                             | <p>Je nach <b>Ursache!</b><br/> 1. <b>Prednison</b> Tbl. (10T.)<br/> 2. ev. <b>Valtrex</b> (Valaciclovir)*<br/> 3. <b>Augentropfen</b>/Salbe + <b>Uhrglasverband</b> falls Bell-Parese</p> <p>*falls Virus, auch wenn nicht erwiesen in Serologie!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><u>Ursachen</u>: entzündlich/infektiös, Traumatisch, Tumorbedingt</p> <p><u>Periphere FP</u>: Stirnmuskulatur ausgefallen (meist idiopath., infektiös &gt;Borreliose, HSV, HIV), traumatisch</p> <p><u>Zentrale FP</u>: Stirnmuskulatur intakt, ZNS-Problem (Tumor, MS, CVI)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## RACHEN

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Tonsillitis</b> (nur Tonsillen/Mandeln)                           | Hals-Sz., Odynophagie, Dysphagie, oft Reflexotalgie (beim Schlucken), meist unilateral., akut od. chron., Globusgefühl, ev. Fieber, AZ, Kopf-Sz., LK-Schwellung, klossige Sprache                                                                                 | <b>Inspektion Mund + Rachen</b> (weissl. nicht-konfl. Beläge >Stippchen, Schwellung Tonsillen, Rötung)<br><b>Lymphknoten</b><br><b>Inspektion + Palpation Hals</b> (Abszess)<br><b>Ohr + Nase</b> untersuchen                                                                                                                                                                       | <b>Tonsillenabstrich + Strepto-Test), ev. BE (LK, CRP), Fieber messen</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>AB</b> (Augmentin, falls bakteriell), <b>Lutschtabletten</b> (Analgesie) <b>NSAID</b> ev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | In ersten 24h ansteckend (Tröpfchen).<br><u>Syn</u> : Angina tonsillaris/lacunaris<br><u>Erreger</u> : meist bakteriell (Strep. A), selten EBV (starke Beläge, Grippe-Symp., Müdigkeit, langer Verlauf) |
| <b>Peritonsillarabszess, Parapharyngealabszess, Retropharyngealabszess</b> | Meist i.R. od. nach akuter Tonsillitis od. Zahnproblem/behandlung, Hals-Sz., meist unilateral, Odyno- bis Dysphagie, Trismus, hohes Fieber, Aphagie, red. AZ<br><u>Retroph.Abszess</u> : Torticollis, Dyspnoe, weniger Sz als bei Para- oder Peritonsillärabszess | <b>Inspektion Mund + Rachen</b> ( <u>Peri</u> : einseitige Rötung + Schwellung Uvula/Wiechgaumen+ hinter Tonsille mit Verlagerung Gaumensegel >Kulissenph., <u>Para</u> : enorale parapharyngeale Schwellung, <u>Retro</u> : enorale prävertebrale Schwellung).<br><b>Lymphknoten</b><br><b>Inspektion + Palpation Hals</b> (ev. Schwellung + Sz.)<br><b>Ohr + Nase</b> untersuchen | <b>Hospitalisation, PVK + BE</b> (CRP, BSG, Linksversch.), <b>Fieber</b><br><br><u>Peritonsillarabszess</u> : i.d.R. <b>klinische Dx</b> , CT (KM) möglich<br><u>Parapharyngealabszess</u> : <b>CT</b> (KM)<br><u>Retropharyngealabszess</u> : <b>CT</b> (KM)<br><br>(US schlecht) | <u>Peritonsillarabszess</u><br>1. <b>Spaltung Abszess</b> (Drainage) in LA + tgl. <b>Spreizen + Spülen</b> od. <b>Abszess-TE</b> (à Chaud), <b>AB</b> , <b>Kontrollen!</b><br>2. Falls Spaltung <b>TE nach 3 Mt.</b> (à froid) empfohlen<br><u>Parapharyngealabszess</u> : <b>Abszessdrainage</b> (Spaltung) + <b>ev. TE, AB</b> (i.v.)<br><u>Retropharyngealabszess</u> : „“, <b>AB</b> i.v. |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Chron. Tonsillitis</b>                                                  | Fibrosierung d. Tonsillen oft bei Rauchern, sz.-hafte vernarbte Tonsillen, zeigt s. als rezidiv. Tonsillitiden od. ohne Symptome, Abgeschlagenheit, Halitosis                                                                                                     | <b>Inspektion Mund + Rachen</b> (kleine derbe Tonsillen, schlecht luxierbar, peritonsilläre Rötung)<br><b>Lymphknoten</b><br><b>Inspektion + Palpation Hals</b><br><b>Ohr + Nase</b> untersuchen                                                                                                                                                                                    | <b>Labor</b> (BSG + CRP erhöht, Linksverschiebung), <b>Abstrich</b> ev.                                                                                                                                                                                                            | <b>TE</b> (falls Dx. klar und Pat.wunsch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rezidiv. Infekte d. Tonsillen >Fibrosierung                                                                                                                                                             |
| <b>Akute Angina</b> (ganzer Waldeyerscher Rachenring)                      | Hals-Sz., Odynophagie, Dysphagie, oft Reflexotalgie (beim Schlucken), akut od. chron., Globusgefühl, ev. Fieber, AZ, Kopf-Sz., LK-Schwellung                                                                                                                      | <b>Inspektion Mund + Rachen</b> (Rötung/Schwellung Rachen/Tonsillen/etc, ev. Beläge an Rachenhinterwand)<br><b>Lymphknoten</b><br><b>Inspektion + Palpation Hals</b> (Abszess)<br><b>Ohr + Nase</b> untersuchen                                                                                                                                                                     | <b>Rachen- + Tonsillenabstrich (Strepto-Test), ev. BE (LK, CRP), Fieber messen</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>AB</b> (Augmentin, falls bakteriell), <b>Lutschtabletten</b> (Analgesie) <b>NSAID</b> ev.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Akute Pharyngitis</b>                                                   | Odynophagie, Hals-Sz., Symptome eines Infektes d. oberen Luftwege (LK, Fieber, Kopf-Sz., Husten, NAB)                                                                                                                                                             | <b>Inspektion Mund + Rachen</b> (Starke Rötung Rachen, ev. schleimige Beläge)<br><b>Lymphknoten</b><br><b>Inspektion + Palpation Hals</b><br><b>Ohr + Nase</b> untersuchen                                                                                                                                                                                                          | <b>Ev. Rachen-Abstrich</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kein Fieber:</b> <b>NSAID</b> , <b>Gurgeln</b> (antisept.), <b>Hausmittel</b> , viel <b>Trinken</b><br><b>Fieber:</b> <b>AB</b> (Augmentin)<br><br><b>Ist fast immer banal! Häufig!</b>                                                                                                                                                                                                    | Oft viral (Influenza- od. Parainfl.-Viren), z.T. bakteriell<br><br>Meist banale Pharyngitis! 50% d. Hals-Sz. wegen banaler Ph.                                                                          |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chron. Pharyngitis</b>       | Räusperzwang, Reizhusten, FK-Gefühl, i.d.R. keine Hals-Sz.<br><u>RF</u> : Langfristige Exposition gg. noxen (Rauchen, Alk, Chemikalien, Reizgase), Mundatmung, chron. Sinusitis                                    | <b>Inspektion Mund + Rachen</b> (granulierte od. ganz glatte Rachenhinterwand)<br><b>Lymphknoten</b><br><b>Inspektion + Palpation Hals</b> (Abszess)<br><b>Ohr + Nase</b> untersuchen                                                                                                | <b>Endoskopie Nase</b> ( <b>Septumdeviation, Muschelhyperplasie, etc.</b> )                                                                                                  | 1. <b>Noxen</b> weg<br>2. <b>Befeuchtung</b> Atemwege (Inhalation >Salbei, super!), <b>Lutschtabletten, Trinken</b><br>3. <b>Operation</b> (falls anatom. Problem)                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Scharlach</b>                | Hals-Sz., Odynophagie, Otalgie, Husten, hohes Fieber, LK, Enanthem (Rötung Zunge + Mund), Exanthem                                                                                                                 | <b>Inspektion Mund + Rachen</b> (initial weissl. belegt, dann Himbeerzunge, Tonsillen dunkelrot geschwollen, Rachen gerötet)<br><b>Lymphknoten</b><br><b>Inspektion + Palpation Hals</b> (Abszess)<br><b>Ohr + Nase</b> untersuchen<br><b>Haut</b> : stechnadelkopf-grosses Exanthem | <b>Strepto-Schnelltest</b><br><b>Fieber messen</b>                                                                                                                           | <b>AB</b> (Augmentin)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B-Hämolysierende Strept. A (wie Akute Tonsillitis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nekrotisierende Faszitis</b> | Bleibt nicht in Logen drin, Gefahr einer Mediastinitis                                                                                                                                                             | <b>Inspektion und Mund und Rachen, LK, Hals Inspektion und Palpation, Nase und Ohren untersuchen</b>                                                                                                                                                                                 | <b>CT/MRI</b>                                                                                                                                                                | <b>AB oder Notfallcervikotomie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tonsillennachblutung</b>     | Blutung aus Mund, ev. Bluthusten, Dyspnoe, ev. kreislaufinstabil, ev. Schock (Pat. versterben am Verstickten von Blut)                                                                                             | <b>1. Inspektion Tonsillenlogen</b><br>2. ev. Laryngoskopie                                                                                                                                                                                                                          | > <b>Hospitalisation: NOTFALL!</b><br>1. grosslumiges <b>PVK</b> (sofort), Testblut<br>2. <b>Kompression</b> (Tamponade, Finger)<br>3. <b>Intubation</b> (Gefahr Aspiration) | 1. <b>Naht</b><br>2. <b>Ligatur</b> A. carotis externa<br>3. <b>Embolisation</b>                                                                                                                                                                                                                                  | Falls nur leichte Nachblutung (sog. <b>Warnblutung</b> ) >Hospital. zur Überwachung (engmaschige Rachenkontrollen, grosslumiger Zugang), falls erneute Blutung OP                                                                                                                                                                                                      |
| <b>LARYNX</b>                   |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Stimm lippenprobleme</b>     | Stimmanamnese (Heiserkeit, stimme leiser, Aphonie, Diplophonie >Polyp, Chrott im Hals, etc.), Heiserkeit (einseitige Stimm lippenlähmung), Dyspnoe (bds. Lähmung), Infekt, Rauchen, Alk, Psyche/Stress, B-Symptome | <b>Stimmstatus</b> : auditiv<br>>Standardlesetext, akustisch<br>>Stimmfeld- + -schall-Analyse<br><b>Laryngo- + Stroboskopie</b><br><b>Gehör testen</b><br><b>Lymphknoten</b>                                                                                                         | Endoskopie                                                                                                                                                                   | <b>Je nach Ursache</b><br><br><b>Chirurgie</b> (Tumoren, bds. Stimm lippenlähmung), ev. <b>Chemo</b> , ev. <b>Silikoninjektion</b> (Verbesserung Stimm lippenanschluss), <b>Logopädie/Stimmtherapie</b> (Heiserkeit, einseitige Stimm lippenlähmung), <b>Psychologie</b> (funkt. Störungen)<br><br>*RT, Laser ev. | <u>Pathologien</u><br><b>Stimm lippenlähmung</b><br><b>Benigner Tumor</b> ( <b>Papillom</b> (evtl. <b>Dyspnoe</b> )/ <b>HPV</b> , Zyste ( <b>wechselnde Stimme</b> ), <b>Polyp</b> ( <b>diplophon</b> ))<br><b>Maligner Tumor</b> ( <b>Stimm lippen-Ca*</b> )<br><b>Funktionelle Dysphonie</b> (keine organ. Ursache od. organ. Problem als Folge v. Belastung/Stress) |

|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akute Laryngitis</b>                                                       | Hals-Sz., rauhe/belegte/heisere Stimme, oft Zeichen v. Infekt d. oberen Luftwege (Rhinitis, Husten, etc.), evtl. Atemnot (NOTFALL!!!)                                                                                | <b>Inspektion Mund + Rachen</b><br><b>Laryngoskopie</b> (Schleimhautschwellung, starke Rötung, Schleim)<br><b>Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                        | <u>Symptomatisch</u><br>Stimmerschonung, Hausmittel, viel Trinken, Inhalationen (NaCl, Salbei), <b>NSAID</b><br><br>Infekt dauert ohne + mit Arzt gleich lang.                        |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Chron. Laryngitis</b>                                                      | Heiserkeit, FK-Gefühl, tiefe Stimme<br><br>RF: chron. Reize (Nikotin)                                                                                                                                                | <b>Inspektion Mund + Rachen</b><br><b>Laryngoskopie</b> (trockene Schleimhaut, zäher Schleim mit Fibrinbelägen, Stimmlippen gerötet)<br><b>Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr</b>                        |                                                                                                                                                                                                        | 1. Noxen weg (Nikotinstopp)<br>2. Inhalation ( <b>Acetylcystein</b> >Expectorans, <b>NaCl, Cortison</b> )<br>3. viel Trinken<br>4. <b>NSAR, PPI</b> falls Reflux,<br>5. Stimmtherapie |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Epiglottitis</b> (Kinder Hib, Erwachsene Staph aureus, Streptokokken etc.) | Hohes Fieber, inspirat. Stridor, Atemnot, z.T. Heiserkeit + Husten, klossige Sprache (Hot-Potatoe), Odynophagie, Speichelfluss                                                                                       | <b>Inspektion* Mund + Rachen</b> (Rachenwand gerötet)<br><b>Laryngoskopie</b> (Epiglottis stark geschwollen + hochrot >rote Kirsche, ev. Abszess)<br><b>Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr</b>           | BE (CRP, Linksversch.), Blutkultur<br><b>Anästhesie</b> (Intubation, oft als 1. Massnahme um Atemweg zu sichern, denn Lage kann s. abrupt verschlimmern!), ev. <b>CT</b><br><br><b>Hospitalisation</b> | <b>NSAID, Adrenalin</b><br><b>Intubation, AB (Augmentin),</b><br><br><b>Prophylaxe:</b> Impfung gg. H. infl. Typ B (dann 0% Mortalität)                                               | <b>Lebensbedrohlich in 10%!</b><br><br>*vorsichtig denn reflekt. Atemwegsverlegung möglich!<br><br>DD: Pseudokrupp (viral), Krupp (Diphtherie)                                                         |
| <b>Pseudokrupp / Akute subglott. Laryngitis)</b>                              | Meist Säuglinge + Kleinkinder, oft Frühling od. Herbst, abends/nachts, trockenbellender rauher Husten, insp. Stridor, Atemnot, Zyanose, Heiserkeit, ev. Fieber                                                       | <b>Inspektion Mund + Rachen</b><br><b>Laryngoskopie</b> (subglott. Stenose)<br><b>Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr</b>                                                                                 | BE (keine Leukozytose)                                                                                                                                                                                 | <b>Anfeuchtung</b> Atemluft, <b>Flüssigkeit, orale Steroide, Inhalation Adrenalin</b> (Abschwellung)                                                                                  | <u>Echter Krupp:</u> falls Diphtherie, enorm selten!                                                                                                                                                   |
| <b>Laryngo-Tracheitis</b>                                                     | Sporadisch (keine jahreszeitl. Häufung), Säuglinge + Kleinkinder, langsamer Beginn mit Rhinitis/Pharyngitis, in- + expirat. Stridor, RG über Lungen, ev. Fieber(Verschlimmerung kann auch plötzlich nachts erfolgen) | <b>Inspektion Mund + Rachen</b> (Mukosa gerötet)<br><b>Laryngoskopie</b> (Mukosa im ganzen Trakt gerötet, Stimmlippen + subglottisch gerötet + geschwollen)<br><b>Lymphknoten, Hals, Nase, ev. Ohr</b> | BE (Linksversch.), ev. Intubation                                                                                                                                                                      | 1. <b>AB (Augmentin), Acetylcystein</b><br>2. <b>Anfeuchtung</b> Atemluft, <b>Flüssigkeit</b>                                                                                         | <b>Gefahr f. Atemwege!</b>                                                                                                                                                                             |
| <b>NASE</b>                                                                   |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Riechstörung</b>                                                           | Hyposmie, Anosmie, Hyperosmie, spez. Anosmie, Parosmie/Kakosmie, Phantosmie, fragen ob Trigemini (Temp., Sz., etc. ok), fragen ob Geschmack (5 Qualitäten) ok, Rauchen, Alk                                          | <b>Inspektion Nase</b><br><b>Rhinoskopie</b> (E., Blutung, Septum, Polypen, Tumor)<br><b>Mund/Rachen untersuchen</b>                                                                                   | <b>Riech- + Schmecktest</b> (Pat. verwechseln beides oft)<br><br>Nasale <b>Endoskopie</b> (Polypen, Tumoren, Schleimhaut)<br><br><b>Serologie</b>                                                      | Je nach Ursache<br><br>- <b>Chirurgie</b><br>- <b>Noxenstopp (Medi, Rauchen)</b><br>- <b>Steroide top.</b><br>- <b>Smell Training</b>                                                 | Oft keine kausale Behandlung, Prognose eher gut weil Riech-EP s. regeneriert<br>Gute Prognose bei Riechverlust wenn: Parosmie, kurze Erkrankungsdauer, junges Alter, nicht rauchen, hoher Initialscore |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | Trigger: Polypen, Infekte, SHT, Alter, Alzheimer, Parkinson, Psyche, Medis (Antimykotika)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MRI, CT<br><br>Neurolog. Konsil, ev. Psychiatrie                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Epistaxis                           | Nasenbluten, ev. Bluthusten, Dyspnoe, ev. kreislaufinstabil, ev. Schock<br>Trigger: Trauma, trockene Mukosa, Rezidiv, Antikoagul., FK, Tumor, Hypertonie, trockene Luft, Infekt                                                                                                                                                                                                                               | 1. Pat. <b>beruhigen</b> , aufrecht <b>hinsetzen</b> , <b>Blut nicht schlucken</b><br>2. Kompression Nasenflügel<br>3. <b>Eiskrawatte</b> (Nacken)                                                                                                                                                                                     | Monitoring (BD u.a.)<br>PVK + BE (Testblut u.a.)<br><br>Endoskopie (falls rezidiv.)<br>Angiographie ev., ev. CT/MRI                                                                                                                                                                                                   | 1. <b>Inspektion + Nase reinigen</b> (Koagel raus) unter <b>LA</b><br>2. <b>Blutungsstopp</b> : Verätzung, Kauterisation, Tamponade, Ligatur, Embolisation, OPs falls alles nichts bringt, <b>Tamponade*</b><br>3. <b>Detamponade</b> (nach 2-3 T.)<br>4. Schneutznverbot 7 T., keine Hitze                                                                                                                                                                           | Häufig, selten gefährlich (Gesichts-Fx, M. Osler, Aspiration v. Blut), meist selbstlimitierend<br><br>*ev. <b>AB</b> , bei bds. Tamponade immer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Akute Rhinosinusitis ARS (<4 Wo.)   | <u>Viral</u> : Rhinorrhoe, Dyspnoe/NAB, Hyposmie, Gesichts-Sz. (beim Bücken u.a.), OLW-Infekt, Fieber, Husten, Halsweh, Kopf-Sz., Otalgie, Dauer(<8-10T.), guter AZ meist, Asthma, Zahnweh (dentogene S.)<br><u>Bakt. ARS, ev. mit Komplikat.</u> : Symptome wie oben, aber Verschlimmerung nach 3-5 T. + >10T. Dauer, red. AZ, grüngelbes Sekret, ev. Meningismus, Weichteilschwellung, Zahn-Sz., sept. Bild | <b>Inspektion</b><br><b>Palpation</b> : Nervenaustrittspunkte, Klopfdolenz NNH, Pat. soll s. bücken<br><b>Rhinoskopie</b> (Sekret, E., Schwellung)<br><b>Racheninspektion</b> (Drip? Rötung)<br><b>Untersuchung Ohren</b> (Otoskopie, Palpation, Stimmgabel + Hörtest)<br><b>Ev. Lunge</b> (Auskult. bei Husten)<br><b>Lymphknoten</b> | Ist eine klin. Dx, aber Facharzt kann zusätzlich machen:<br><br><b>Diaphanoskopie</b> , ev. <b>BE</b><br>Ev. <b>NPS</b> (klin. Dx reich aber), <b>Endoskopie</b> , (Rx/CT erst bei Persistenz od. Komplikat.)<br><br>* <b>Kontrolltermin</b> (nach 1 Wo.), falls keine Besserung: wohl bakt. Infekt > <b>AB</b> geben | <b>VIRALE ARS*</b> : sympt. Th.<br><u>Lokal</u> : <b>Abschwellende Trpf.</b> ( <b>Xylomethazolin/Otrivin</b> ), <b>NaCl</b> -Spülungen, <b>Steroid-Spray</b> , <b>Creme</b><br><u>Systemisch</u> : <b>Abschwellende Tbl.</b> (Ephrin/ Phenylephrin)<br>> <b>Otrinol/Rhinopront, NSAID</b><br><u>Inhalationen</u> : <b>Aether. Oele</b><br><br><b>BAKTERIELLE ARS</b> : wie oben, zusätzlich <b>AB (B-Lactam/Penicillin)</b><br><br>Mukolytika + Antihist. Kein Effekt | Meist (90%!) i.R. viraler Infekte, dann <10T + Symptome nehmen nicht zu nach 3-5T. Komplette Erholung<br>AB gibt man nur wenn s. schwere Symptomatik (auch wenn <10 T.) od. falls Symptome >10T. od. wenn sympt. Th. bei V.a. viralen Infekt nicht greift. Zeichen f. bakt. RS: Zahn-Sz., purulentes Sekret<br><br>Weitere Formen: <b>Pilzsinusitis</b> , <b>dentogene S.</b> , <b>Rhinosclerom</b> , <b>atrophe Rhinitis/Rh. Sicca</b> , <b>Empty Nose</b> , <b>Leishmania-RS</b> , <b>Baro-S.</b> , <b>Bade-S.</b> , <b>Silent Sinus Sy</b> , <b>hormonelle RS</b> , <b>Medikamentöse RS</b> , <b>idiopath. RS</b> |
| Chron. Rhinosinusitis CRS (>12 Wo.) | Symptome wie bei ARS aber mehrere Wo.! ev., Polypen, Dauer (>12 Wo.!)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Sinuspunktat</b> (Gramfärbung, Kultur, Resistenz)<br><b>BE</b><br><b>Endoskopie</b> (Polypen, RF), <b>CT/Rx</b><br>Evtl. Allergietest                                                                                                                                                                              | <b>Top. + syst. Steroide</b> , <b>selten AB</b> (aber nur gut wenn 8-12 Wo.!), <b>Antihistaminika</b> falls Juckreiz, <b>NaCl</b><br><br>Mukolytika + Abschwellende Medis kein Effekt                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Oft weil Polypen<br><br>Nicht komplette Erholung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Allergische Rhinosinusitis          | Typischerweise JUCKREIZ, NAB, Rhinorrhoe (wässrig-klares Sekret), Niessreiz, ev. Asthma, Konjunktivitis, Allergien/ Trigger (Pollen, Milben, etc.), oft +FA, oft ganzer HNO-Bereich betroffen, Jucken im Ohr, postnasal-Drip, Husten                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Ev. Prick- + Patchtest</b><br><b>BE (IgE)</b><br><br><b>SIT</b> in Erwägung ziehen!                                                                                                                                                                                                                                | <b>Intermittierende AR</b> (<4T/Wo od. <4 Wo)<br><b>Orale H1-Blocker</b> , falls s. starke Symptomatik ev. <b>top. Steroide</b><br><br><b>Persistierende AR</b> (>4T/Wo + >Wo)<br><b>Top. Steroide*</b> + ev. <b>orale H1-Blocker</b> , falls starke Obstruktion kurzzeitig <b>orale Steroide</b>                                                                                                                                                                     | *am besten an lat. Nasenwand sprayen (zur Osteomeat.Einheit)<br><br>DD: <b>idiopat. Rhinosinusitis</b><br>Anfallsartig waessrige Rhinorrhoe, NAB, Niesreiz (wie allerg. Rhinitis), Trigger: Kalte Luft, heisse Getraenke, Schwefelstoffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Polypsis nasi</b>        | Abgeschlagenheit, NAB, Obstruktion, Rhinorrhoe, Post-Nasal-Drip, <u>Hyposmie/Anosmie</u> , Kopf- + <u>Gesichts-Sz.</u>                                                                                           | <b>Inspektion</b><br><b>Palpation:</b> Nervenaustrittspunkte, Klopfdolenz NNH, Pat. soll s. bücken<br><b>Rhinoskopie</b> (Sekret, E., RF)<br><b>Racheninspektion</b> (Drip? Rötung, Polyp)<br><b>Untersuchung Ohren</b> (Otoskopie, Palpation, Stimmgabel + Hörtest)<br><b>Ev. Lunge</b> (Auskult. bei Husten)<br><b>Lymphknoten</b> | Therapie: <b>Chirurg. Entfernung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Bilaterale Polypen bei Kindern &gt;CF, prim. Ziliendyskinesie</b><br><b>Systemerkrankungen</b> mit Polypen: <b>Churg-Strauss, M. Widal</b><br><b>DD: Schneiderpapillom</b> (Einstülpungen, Präkanzerose v. PE-Ca!)<br><b>DD: Mucozele</b> (Mukosa-Ausstülpung mit Mukus)                                     |                                                                                                                                                         |
| <b>Tumoren</b>              | <u>Unilateral, NAB, Epistaxis, Anosmie</u> , Obstruktion, oft <u>Hypästhesie V2 + Epiphora</u> (Tränenträufeln), LK-Schwellung<br><br>B-Symptome                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Biopsie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Chirurgie, ev. RT/Chemo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Haut:</u> <b>Basaliom</b> (H-Zone), <b>Spinaliom, Melanom</b><br><br><u>Nasenhöhle:</u> <b>PE-Ca, Adeno-Ca, Speicheldrüsen-Ca</b> , Melanom, Lymphom |
| <b>Entzündungen</b>         | <b>Rosazea</b> (Rhinophym)<br><b>H. Zoster</b> (Hutchinson-Z.)<br><b>Erysipel</b> (flache Rötung/Schwellung, Ohrläppchen beteiligt)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Furunkel</b> (tiefe E. v. Haarfollikel), SLE (Schmetterlingserythem)<br><b>Lupus pernio</b> (Sarkoidose an Nase, notig, z.T. Ulzera)<br><b>Rhinophym</b> (i.R. Talgdrüsenhyperplasie: Tetracyclin/Isotretinoid od. Dermabrasie/Laser)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>Anatomische Probleme</b> | Septumdeviation/Schiefnase<br>Leistenbildung                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Nasenform<br>Muschelhyperplasie<br>Polypen<br>Adenoidhyperplasie bei Kindern (Schnarchen, chronische Mundatmung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>OSAS</b>                 | Schlaf, Schnarchen, Nasen- od. Mundatmung, Tagesschläfrigkeit, intellektueller Leistungsabfall, Impotenz, Enuresis, Hypertonie                                                                                   | <b>Mund + Rachen</b> (Tonsillenhypertrophie, Retrognathie, grosse Uvula)<br><b>Nase</b> (Septumdeviation, Polypen), <b>Laryngoskopie</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Endoskopie</b> mit Müller-Manöver (Obstruktionstest), <b>Polysomnographie, Schlaflabor</b><br><br>Einstufung Schweregrad: <b>AHI-Index</b> (Apnoe-Hypopnoe-Ereignisse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Konservativ:</b> Gewichtsred., Trigger vermeiden (Alk, Rauchen, Sedativa), Schlafposition (keine Rückenlage), orale + nasale Devices, CPAP-Beatmung<br><b>Chirurgisch:</b> Septumplastik, Chonchotomie, NNH-Op, TE, Weichgaumen-Straffung, Hyoidsuspension, Tracheotomie >multilevel-Chirurgie M.d.W.        | <u>Pulsoxymetrie:</u> viele Falsch-Negative!<br><br><b>DD:</b> habituelles Schnarchen (Benigne), UARS                                                   |
| <b>OHR</b>                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                         |
| <b>Schwerhörigkeit</b>      | <u>Anamnese</u><br>Otorrhoe, Otalgie, Hypakusis-Grad, Tinnitus, Schwindel, Fieber, AZ, etc.<br><b>RF:</b> Alter, DM!, +FA, Pegel/dB, Knalltrauma, rezidiv. Otitiden, Infekte obere Atemwege<br><br><u>Status</u> | <u>Untersuchungen</u><br>- <b>Audiometrie</b> (Reinton, Sprache),<br>- <b>Tympanogramm</b><br>- <b>Stapediusreflexe</b><br>- <b>OAE</b><br>- <b>ERA</b><br><br>- ev. <b>Bildgebung (CT, MRI)</b>                                                                                                                                     | <u>Therapie</u><br><b>Schallempfindungsproblem:</b><br><b>Presbyakusis</b> (Schalleitung- + Schallempf v.a. f. hohe Freq. progressiv langsam verschlechtert, symmetrisch, bds., Hörschwelle höher, Otoskopie + Stimmgabeltests. normal) > <b>Hörgerät falls &gt;40 dB</b><br><b>Infekte</b> (Röteln, Syphilis) > <b>AB</b> od. <b>sympt.</b> (viral)<br><b>FG, Knalltrauma (CS-Senke)</b><br><b>Hörsturz</b><br><b>Ototox. Medis (Amiodaron, AB etc.)</b> >Medi <b>absetzen</b> , ev. <b>Hörgerät</b> | <b>HÖRGERÄT</b><br><b>Mildes Schallempfindungsproblem:</b> <u>Schallverstärker-Hörgerät</u> (ausser s. ausgeprägt) od. <u>Knochen vibrator/BAHA</u><br><b>Schwere Schallempfindungsstörung</b> <u>Cochlea-Implantat</u> (präop. Bildgebung nötig, CT + MRI, bei bds <30dB Hörschwelle), <u>Hybrid-CI</u> (falls |                                                                                                                                                         |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | <b>Inspektion Ohr,</b><br><b>Stimmgabeltests</b> (Weber, Rinne), <b>Hörtest</b> (Flüsterzahlen),<br><b>Otoskopie,</b><br><br><b>Vestibularsystem</b> testen (Unterberger-Tretversuch, Strichgang, Rhomberg, Nystagmusprüfung) |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>M. Meniere</b> (Tinnitus, Tieftonschwerhörigkeit und Drehschwindel)<br><br><b>Schalleitungsschwerhörigkeit:</b><br><b>Cerumen obturans</b> > <b>Ohrspülung</b> , <b>Otosklerose</b> > <b>Ops</b> Gehörknochen, <b>FK</b> > <b>Entfernung</b><br><b>Gehörgangsatresie</b> > <b>Ops</b> , <b>Belüftungsstörung</b> Mittelohr, <b>Trauma</b> , <b>Otitis media</b> > <b>AB</b> | Restgehör in tiefen Freq.)<br><b>Schalleitungsproblem</b><br><u>Schallverstärker-Hörgerät</u> od. <u>Knochenvibratoren</u> + <u>BAHA</u> (falls Schallverstärkungsgerät n. möglich)<br><br>Wichtig: <b>Regelmässige Kontrollen</b> nötig!                                                                                                                                                                                |
| <b>Hörsturz</b>                            | Plötzlicher Hörverlust, Rauschtinnitus, Völlegefühl im Ohr, kein Schwindel                                                                                                                                                    | <b>Inspektion äusseres Ohr</b><br><b>Palpation</b><br><b>Gehör testen:</b> Weber ins Gesunde, Rinne knapp + od. ne+ bds., Hörtest (Hypakusis)<br><b>Otoskopie</b> o.B.<br><b>Lymphknoten</b>                                                                                               | 1. <b>Serologien</b> + alle weiteren <b>Untersuchungen</b> (Audiometrie, Tympanometrie, Stapediusr., MRI*, BERA*) o.B.<br>2. <b>Hospitalisation</b>                                                                                                                                                                                                                            | 1. <b>Kortison</b> i.v.<br><br><u>Ursache</u> unbekannt >Ausschluss-Dx<br><br>*um Tumor auszuschliessen (v.a. bei rez. Gehörstürzen Oticusneurinom ausschliessen)                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Tinnitus</b>                            | Ohrgeräusch, pulsierend, Rauschend, Ton, immer gleich, Hypertonie, bei Stress mehr                                                                                                                                            | <b>Otoskopie</b><br><b>Stimmgabeltests</b><br><b>Hörtests</b><br><b>Neurostatus</b><br>➤ Alles o.b.                                                                                                                                                                                        | BD-Messung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BD-Senkung + BD-Kontrollen HA<br><br>Jedes subj. Ohrgeräusch = Tinnitus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fashion Injury</b>                      | Ohrschmuck, progrediente Ausdünnung Ohr läppchen + ev. Ausriss                                                                                                                                                                | <b>Inspektion äusseres Ohr:</b><br>Ohr läppcheneinriss, keine Knorpelschäden                                                                                                                                                                                                               | ambulant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. <b>Naht</b> , ev. lokaler Lappen<br>2. <b>AB</b> (falls grosse Wunde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Trauma/Verletzung (Hunde biss z.B.)</b> | Verletzung, Blutung, Hypakusis, Otorrhoe, Otalgie, Tinnitus, Schwindel, alles fragen<br><br>*Falls Verletzung mit Gegenstand                                                                                                  | <b>Inspektion äusseres Ohr:</b><br>Verletzung Ohrmuschel, Knorpelbeteiligung?<br><b>Palpation</b><br><b>Gehör testen:</b> Stimm. + Hörtest<br><b>Otoskopie:</b> ev. Blut im Gehörgang, ev. Hämatotympanon, ev. Perf.<br><b>Vestibularsystem</b><br><b>Neurostatus</b> (ev. Fazialisparese) | Ev. <b>Hospitalisation</b> , Bildgebung<br><b>CT</b> (Ausschluss Fx)<br><br><u>Therapie</u><br>1. <b>Reinigung</b> Wunde, <b>Naht</b> , ev. Lappen<br>2. <b>Tetanus-Rapell*</b><br>3. <b>AB</b>                                                                                                                                                                                | <u>Falls Ohrteil abgetrennt:</u> mit Plastik umhüllen + kühl lagern (ev. Eis)<br><br><u>Felsenbein-Fx</u><br><b>Längs-Fx:</b> durch Mittelohr, Blut Gehörgang, ev. TF-Perf., ev. Liquorrhoe, Schalleitungsproblem (>Weber ins Kranke, Rinne neg.), ev. Fazialisparese<br><b>Quer-Fx:</b> durch Innenohr >Hämatotympanon, intaktes TF, Vestibularis-Ausfall (Schwindel), Cochlearis-Ausfall (Taubheit >Weber ins Gesunde) |
| <b>Perichondritis</b>                      | Schmerzen an Ohrmuschel, Schwellung                                                                                                                                                                                           | <b>Inspektion äusseres Ohr:</b><br>Schwellung Helix ohne Ohr läppchenbeteiligung (bei Erysipel O-Läppchen auch!), Zeichen der E. + Infektion<br>Ohrmuschel mit Knorpelbeteiligung                                                                                                          | Hospitalisation, PVK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1. <b>AB</b><br>2. <b>Inzision</b> falls Abszess (sonst Knorpelnekrose)<br>3. Kühlende <b>Umschläge</b><br><br>E. Ohrknorpel >Gefahr Nekrose d. Knorpels<br><br>DD: <b>Ohrmuschelerysipel</b><br>>Ohr läppchen auch beteiligt! >i.v. <b>AB</b>                                                                                                                                                                           |

|                               |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoster oticus                 | Sz., Bläschen am Ohr, red. AZ, Fieber, ev. Fazialisparese, ev. Geschmacksstörungen, ev. Hypakusis, ev. Rhinorrhoe, ev. Schwindel                                                      | <b>Inspektion äusseres Ohr:</b><br>Bläschen, Krusten<br><b>Palpation</b><br><b>Gehör testen:</b> Stimmgabel, Hörtest<br><b>Otoskopie</b> (ev. Otitis externa +/- od. media)<br><b>Vestibularsystem testen:</b><br>Nystagmus, ev. Kalorik<br><b>Neurostatus:</b> Sensibilität (Dermatom), Fazialisfunktion, Geschmack, Romberg | Hospitalisation, PVK, ev. Ophta-Konsil<br><br>1. <b>Abstrich</b> (Bläschengrund)<br>2. <b>Serologie</b> (AK)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Antivirale Th. <b>Valaciclovir*</b><br>2. <b>Analgesie</b> (NSAID)<br>3. <b>Zink-Tinktur</b> lokal (Wundheilung)<br><br>*bei Alten auch noch 5-7 T. nach Syptombeginn um Risiko für <b>postzosterische Neuralgie</b> zu senken.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |
| FK od. Cerumen obturans       | FK-Gefühl, Hypakusis, ev. Rhinorrhoe, oft nach Baden/ Duschen, Tinnitus                                                                                                               | <b>Inspektion äusseres Ohr</b><br><b>Palpation</b><br><b>Gehör testen:</b> Weber (lat. ins Kranke), Rinne (leicht + od. neg. am betroffenen Ohr), Hörtest<br><b>Otoskopie</b>                                                                                                                                                 | *Pat. über Risiken aufklären (Sz., Schwindel, Perf.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. <b>Entfernung Cerumen</b> (Sauger, Häkchen, Zange, Spülung* falls keine TF-Perf.!)<br>2. <b>Entfernung FK</b> (in <b>LA/Xylocainsray</b> )<br><br>Kinder: ev. Sedation nötig!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Cerumen:</u> Wasser macht, dass Cerumen aufquillt >nimmt Cerumen stärker wahr<br><u>FK:</u> Stimmgabeltests o.B.<br><u>Zecke:</u> Xylocainspray + mit Zange entfernen |
| Akute Otitis media            | Kürzlich Krank (obere Atemwege >Rhinitis, Husten, Halsweh), Hypakusis, hoch Fieber, starke Otalgie, ev. Otorrhoe, red. AZ, meist kein Schwindel<br><br><u>RF:</u> Infekt ob. Atemwege | <b>Palpation:</b> Tragusdruck- + zug (eher Otitis externa), Mastoid<br><b>Gehör testen:</b> Stimmgabel* + Hörtest<br><b>Otoskopie</b> (gerötetes TF, ev. Perf.)<br><b>Lymphknoten</b><br>Ev. <b>Nase</b> untersuchen<br><b>Meningismus</b><br><br>* Weber ins Kranke, Rinne + (falls s. starke E. neg.)                       | <u>Beginnende O. media</u><br>1. <b>Symptomat.</b> Th.: <b>Analgesie + abschwellender Nasenspray (Otrivin)</b><br>2. <b>Kontrolltermin in 24h! &gt;AB</b> (Augmentin) falls keine Besserung<br><br><u>Komplizierte O. media:</u> Schwindel, s. starke Sz. od. Perzeptions.hörigkeit:<br>1. <b>Parazentese/Paukendrainage, AB i.v.</b><br><br><u>Komplizierte O. media mit Mastoiditis, Fazialisparese od. ZNS-Problem &gt;CT</u><br>1. <b>Parazentese* + Mastoidektomie</b> (Eiterablass) falls Mastoiditis<br>2. <b>Hospitalisation + PVK: AB i.v., Analgesie, Tropfen</b> (Abschwellung, Desinfektion)<br>3. Regelmässige <b>Reinigung</b> Gehörgang + <b>Spülung</b> | <u>Komplikationen:</u> <b>TF-Perf., Hörverlust, Akute Mastoiditis:</b> absehendes Ohr + Rötung Mastoidregion<br>*nie im hinteren oberen Quadranten<br>- <b>Labyrinthitis:</b> Schwindel<br>- <b>Cochlea-Beteiligung:</b> Innenohrschwerhörigkeit<br>- <b>ZNS-Beteiligung:</b> Meningitis, Sinusv.thrombose, Enzephalitis, Abszess, etc.<br>Falls drohende Komplikation od. schlechte Gefühl (Schwindel, Schallempfindungsstörung, etc.,) kann man auch sofort schon AB geben + muss nicht 24h warten. |                                                                                                                                                                          |
| Otitis media chronica simplex | Keine Schmerzen, Hypakusis (sog. sz-lose Hörminderung), Otorrhoe (bei Erkältung + Kontakt mit H2O)<br><br><u>Ursachen</u> erfragen: O. media vorgängig, Trauma                        | <b>Palpation:</b> Tragus, Mastoid<br><b>Gehör testen:</b> Stimmgabel* + Hörtest<br><b>Otoskopie</b> (gerötetes TF, <u>zentrale Perf.</u> , Otorrhoe)<br><b>Lymphknoten</b>                                                                                                                                                    | *Weber ins Kranke, Rinne + (falls s. starke E. neg.)<br>Ev.<br><b>Audiometrie</b> (Transmissionss.)<br><b>Tympanometrie</b> (abgeflacht)<br><b>Stapediusreflexe</b> (schwach)<br>OAE, ERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1. <b>AB</b> p.o. + Trpf.<br>2. Falls Pilz: <b>Antimykotika</b> -Trpf. od. <b>Essigsäure</b> (sz.haft)<br>3. <b>Tympanoplastik</b> (Verschluss TF)<br>4. ev. <b>Ossikuloplastik</b> (falls G-Knöchelchen zerstört)<br>Pat. soll <b>kein H2O</b> ins Ohr lassen!                                                                                                                                                                                                                                       | <u>Pathogenese:</u> ist Folge einer bleibenden Perf. nach O. media, Trauma, Dysfunktion Tuba eu., etc.                                                                   |
| O. media chronica seromucosa  | Schmerzlose Hoerminderung, keine Infekzeichen, kein Krankheitsgefühl                                                                                                                  | <b>Gehör testen:</b> Stimmgabel* + Hörtest<br><b>Otoskopie</b> (TF nicht gerötet! Keine Perf., Paukenerguss)<br><b>Lymphknoten</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Endoskopie</b> (Rachen >Tumor, Adenoid, etc. suchen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Ausschluss Tumor, Tubentraining, ev. Parazentese/Paukendrainage, Adenotomie</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                          |

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Otitis media chronica cholesteatosa / Cholestatom</b> | Keine Schmerzen, Hypakusis (sog. sz-lose Hörminderung), Otorrhoe (bei Erkältung + Kontakt mit H2O)<br><u>Ursachen:</u> Trauma, rezidiv. O., kongenital, etc.<br>(Klinik wie bei O. media ch. s., bei Exazerb. wie akute O.M.!)                                | <b>Palpation:</b> Tragusdruck- + zug, Mastoid<br><b>Gehör testen:</b> Stimmgabel* + Hörtest<br><b>Otoskopie</b> (randständige TF-Perf., Retraktion + PE-Debris/Cholesteatom >typisch oberer hinterer Q., Otorrhoe)<br><b>Neurostatus:</b> Fazialis, Nystagmus<br><b>Lymphknoten</b> | *Weber ins Kranke, Rinne + (falls s. starke E. neg.)<br><br><b>Audiometrie</b> (Transmissionss.)<br><b>Tympanometrie</b> (abgeflacht)<br><b>Stapediusreflexe</b> (schwach)<br>OAE, ERA                                                             | <b>Cholesteatom-Entfernung, TF-Verschluss</b> , ev. Ossikuloplasti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <u>Pathogenese:</u> Belüftungsstörung Mittelohr (TF-Perf. nach rezidiv. Otitiden od. Dysfunktion T. eustachi >Unterdruck >saugt EP rein), kongenitales Cholesteatom (EP-Inseln am falschen Ort), posttraumat. wenn randständige Perf. Oft Infekte, Komplikationen wie bei akuter O. media möglich! |
| <b>Otitis externa</b>                                    | Dumpfes Gehör (nur s. wenig Hypakusis), Otagie, kein Schwindel, ev. Rhinorrhoe, kein Tinnitus, guter AZ, oft nach Baden/Schwimmbad, ev. Juckreiz (Pilz)<br><br>RF: Baden, perf. O. media, DM! (Osteomyelitis), Schwimmer (häufig auch Hyperostosen/Exostosen) | <b>Inspektion äusseres Ohr</b><br><b>Palpation:</b> Tragusdruck-Sz.! Mastoidklopfdolenz<br><b>Gehör testen:</b> Weber ins Kranke, Rinne knapp + od. neg., Hörtest (Hypakusis)<br><b>Otoskopie</b> (E. Gehörgang)<br><b>Lymphknoten</b>                                              | *falls Gehörgang zu eng<br><br><u>Therapie</u><br><b>1. Reinigung + Desinfektion</b><br><b>2. AB-Tropfen</b> (bei TF-Perf. KI >p.o.) od. Meschen-Einlage*<br><b>3.. Analgesie</b><br><br>(Audio: eher o.B., Tympanometrie + Stapediusreflexe o.B.) | <b>Bakt. O. ext. circumscripta:</b> Furunkel/Bibeli im Gehörgang: <b>Inzision in LA, AB Trpf. + p.o.</b><br><b>O. externa mi Pilz:</b> dann typischerweise Juckreiz > <b>Desinfektion, Antimykotikum</b> od. <b>Essig-Trpf., keine AB!</b><br><b>O. externa maligna/necroticans:</b> falls <b>DM</b> vorliegt > <b>syst. AB</b><br><b>Komplizierte O. externa:</b> O. media mit TF, Gehörgangshyperostose (oft bei Schwimmern!), DM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Otosklerose</b>                                       | Hypakusis, sonst keine Symptome, Masern gehabt?<br><br>RF: Masernvirus ev., SS                                                                                                                                                                                | <b>Inspektion äusseres Ohr</b><br><b>Palpation</b><br><b>Gehör testen:</b> Stimmgabeltests*, Hörtest (Hypakusis)<br><b>Otoskopie</b> o.B<br><b>Lymphknoten</b>                                                                                                                      | <b>Audiometrie</b> (Transmissionss- + dann zusätzlich Perzeptionss.)<br><b>Tympanometrie</b> (abgeflacht)<br><b>Stapediusreflexe</b> (schwach)<br>OAE, ERA                                                                                         | <b>1. Stapedektomie</b> (Ersatz durch Prothese) <b>od. Hörgerät</b> (falls schlimm CI sonst Schalleitungshörgerät) (Tauchen KI, Fliegen ok)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *zu Beginn nur Luftleitungs-, dann zusätzlich Schallempfindungsstörung mit der Zeit<br><u>Pathogenese:</u> Verknöcherung Stapes in ovalem Fenster nach Infekt                                                                                                                                      |
| <b>Tumoren (Ohrhaut)</b>                                 | Sz., Vorläuferläsion, B-Symptome, weitere Tumoren                                                                                                                                                                                                             | <b>Inspektion äusseres Ohr:</b> ABCDE (Melanom)<br><b>Palpation</b><br><b>Gehör testen, Otoskopie</b>                                                                                                                                                                               | <u>Untersuchungen:</u> <b>Biopsie</b><br><br><u>Therapie</u><br><b>1. Exzision</b> i.d.R., ev. RT<br><b>2. Staging</b>                                                                                                                             | <b>Chondrodermatitis nodularis Winkler:</b> benigne, sz.hafters Knötchen Ohr läppchen<br><b>Melanom:</b> meist pigmentiert, unscharf<br><b>Basaliom:</b> lokal destruktiv, oft perlgrau-artige Knoten, zentrale Eindellung<br><b>Spinaliom:</b> rötlich, ulzerierend                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## VESTIBULARSYSTEM

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akutes Vestibularisdefizit</b>               | Akuter heftiger permanenter Drehschwindel, Gangunsicherheit, Nausea, Erbrechen, Ohr intakt, keine Provokationsmanöver, keine neurolog. Zeichen, mehrere Tage, oft nach viralem Infekt, einmaliges Ereignis<br><u>Trigger</u> : viraler Infekt! vaskulär | <b>Frenzelbrille/Nystagmus</b> (horizont. Spontannystagmus zur gesunden Seite)<br><b>Kalorik</b> (keine Erregbarkeit/ Untererregbarkeit, Beeinflussung d. Nystagmus)<br><b>Neurostatus</b> : Gang (Ataxie), Romberg (Falltendenz zur kranken Seite), Unterberger (Abweichung zur kranken Seite), FNV, Diadochokinese, Hirnnerven, Augenmotorik<br><b>Gehör</b> (Otoskopie, Stimmgabeltests, Hörtest) o.B.<br>HINTS peripher: Head impuls abnormal zur kranken Seite, Nystagmus unidirektional zur gesunden Seite, Test of skew keine Vertikaldivergenz<br>HINTS zentral: HI normal, Nystagmus bidirektional, TS<br>Vetrikaldivergenz |                                                                                                                                                | <b>PVK</b> f. Leitung, <b>ev. Hospitalisation</b><br><br><b>1. Antiemetika</b> (Primperan)<br><b>2. Vestibuläre Physio</b> (sobald akute Phase durch):                                                                    | <u>Prognose</u> : gut, nach Tagen bis Wo. verschwindet Symptomatik durch Training                                                                                                  |
| <b>Benigner paroxysmaler Lagerungsschwindel</b> | Plötzlicher Beginn<br>>Drehschwindel, Sec. bis Minuten, Kopfbewegungen (zur kranken Seite) lösen es aus, Übelkeit, ev. Erbrechen, Ataxie, viele Wiederholungen, Tage bis Wochen                                                                         | <b>Frenzelbrille/Nystagmus</b> (transit. rotatorischer Nystagmus) >o.B.<br><b>Neurostatus</b> : Gang, Romberg, Unterberger, FNV, Diadochokinese, Hirnnerven, Augenmotorik >o.B.<br><b>Gehör</b> (Otoskopie, Stimmgabeltests, Hörtest) >o.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Ev. Kalorik</b><br><br><b>Dix-Hallpike-Manöver (Kopf drehen zur kranken Seite, dann überhängend abliegen)</b> :<br>>Nystagmus provozierbar! | <b>1. Vestibuläre Physio</b> (Epley- (Kopf zur betroffenen Seite dann seitlich abliegen etc.)+ Semont (Kopf zur gesunden Seite drehen dann abliegen etc.)-Manöver)<br><b>2. Chirurgie</b> (selten, wenn Physio erfolglos) | <u>Pathogenese</u> : Otolithen im Bogengang bzw. auf Cupula weil Trauma/Schleudertrauma/Vestibularis-Neuritis/Idopathisch (Frauen oft)<br><br><u>Prognose</u> : gut, z.T. Rezidive |
| <b>M. Menière</b>                               | <u>Trias</u> : Plötzlich Schwindel (stundenlang), Tinnitus, Hypakusis (fluktuierend, v.a. Tieftonbereich), Erbrechen, Drop-Attacks (Sturz bei Bewusstst. da plötzlicher Tonusverlust), meist chron. (immer wieder)                                      | <b>Frenzelbrille/Nystagmus</b> (kein Nystagmus)<br><b>Kalorik</b> (Unerregbarkeit kranke Seite)<br><b>Neurostatus</b> : Gang, Romberg, Unterberger, FNV, Diadochokinese, Hirnnerven, Augenmotorik<br><b>Gehör</b> (Otoskopie, Stimmgabeltests, Hörtest)<br>>Perzeptionsschwerhörigkeit, AEP normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | <b>1. Antiemetika</b> (Primperan) + <b>Antivertiginosa</b> (Betahistin)<br><br><b>2. Bei Misserfolg Chirurgie</b> (Einlage Pauckendrainage, vestibul. Neurektomie, Labyrinthektomie falls Taubheit)                       | Häufig, Kinder selten, z.T. bds. Möglich<br><br>Prognose: i.d.R. gut                                                                                                               |
| <b>Bilaterale Vestibulopathie</b>               | Gleichgewichtsstörungen, Schwankschwindel/ Betrunkenheitsgefühl, Dunkelheit verstärkt es, opt. Fixation beim Laufen schwierig, Medis, auto-immun-Probleme                                                                                               | <b>Frenzelbrille/Nystagmus</b> (kein Spontannystagmus)<br><b>Kalorik</b> (bds. Unerregbarkeit)<br><b>Neurostatus</b> : Gang, Romberg, Unterberger, FNV, Diadochokinese, Hirnnerven, Augemotorik<br><b>Gehör</b> (Otoskopie, Stimmgabeltests, Hörtest)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | <b>Schwierig!</b> Intensive otoneurolog. Reha                                                                                                                                                                             | <u>Ursache</u> erfragen: oft ototox. Medis! Autoimmun                                                                                                                              |
| HALS                                            |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Larynx- + Pharynx-Ca</b>      | <p><u>Larynx</u>: Heiserkeit, Räusperzwang, Reflexotalgie</p> <p><u>Pharynx</u>: Odynophagie, Dysphagie, blutiger Speichel, Foeter ex ore, Trismus, Hörproblem (einseitiger Paukenerguss, daran danken!), LK-Schwellungen, NAB, Epistaxis, Kopf-Sz., Hirnnervnlähmung, Heiserkeit (falls Larynx mitgefallen), Sz.</p> <p><u>RF</u>: Nikotin, Alk, ev. HPV + EBV</p> | <p><b>Inspektion Hals</b><br/><b>Palpation</b><br/><b>Mund + Rachen</b><br/><b>Laryngoskopie</b><br/><b>Gehör</b>: o.B.<br/><b>Lymphknoten</b></p> <p>(Pharynx-Ca: 1. Zeichen oft LK-Metastasen!)</p>                                     | <p><u>Larynx</u><br/>Laryngoskopie mit Biopsie, ev. Panendoskopie<br/>FNP v. LK<br/>US<br/>Staging: MRI/CT/PET</p> <p><u>Pharynx</u><br/>BE: EBV-Titer<br/>Panendoskopie mit Biopsie<br/>FNP v. LK<br/>US<br/>Staging: MRI/CT/PET</p> | <p><b>LARYNX</b><br/><b>Stimm lippen-Ca</b>: RT, ev. Laser<br/><b>Kleine Larynx-Ca</b>: RT/Laser (falls supraglottisch reicht oft RT nicht &gt;Teilresektion nötig)<br/><b>Grosse Larynx-Ca</b>: RT-Chemo + Neckdissection, partielle od. totale Laryngektomie (temp. Tracheo, bei totaler LE permanente Tracheo. Nötig &gt;Stimmprothese od. eigene Ersatzstimme),</p> <p><b>PHARYNX</b><br/><u>Nasopharynx</u> (Selten): <b>PE-Ca, Lypho-EP-Ca</b> (EBV)&gt; <b>RT-Chemo</b> (Kurat. Ops i.d.R. nicht mehr möglich)<br/><u>Oropharynx</u>: <b>PE-C, Lyphom</b> &gt;Chirurgie + Neckdissection + RT-Chemo, od. nur <b>RT-Chemo</b> (kurativ)<br/><u>Hypopharynx</u>: <b>PE-Ca</b> &gt;"" ev. zusätzlich Larynx-Ops, selten Pharyngo-Laryngektomie (s. schwierig!)</p> <p>Bei LK-Metastasen: <b>Neckdissection</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Lymphadenopathie</b>          | Akut od. chronisch, Infekt d. oberen Atemwege, Fieber, AZ oft red., Sexualkontakt, Tiere, Auslandsreise                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Inspektion + Palpation Hals</b><br/><b>Lymphknoten</b><br/><b>Mund + Rachen (Rötung, Tonsillitis)</b><br/><b>Ohren</b><br/><b>Nase</b><br/><b>Ev. Internist. Status (Lunge)</b></p>                                                 | <p><u>Akute LA</u>: keine Diagnostik &gt;klin. Dx, <b>allenfalls BE</b><br/><u>Chron. LA</u>: <b>BE</b> (LK, CRP, Serologien: EBV, HIV, Toxoplasmose, Syphilis, etc.), <b>US, ev. CT, FNP</b> ev. Keine Biopsie!</p>                  | Therapie Grunderkrankung, symptomatisch, ev. AB, falls Abszess Inzision/Drainage, Medi absetzen falls Medi-bedingte LA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><u>Akute-entzündliche LA</u>: &lt;4 Wo., meist i.R. Infekt obere Atemwege (oft bei Tonsillitis + Pharyngitis)<br/><u>Chronisch-entzündliche LA</u>: &gt;4 Wo., Toxoplasmose, HIV, Tbc, Lues, Katzenkratzkrankheit<br/><u>Arzneimittel-LA</u>: symptomlose LK</p>                                                                              |
| <b>Mumps/Parotitis epidemica</b> | Schwellung Wange, Beginn einseitig + nach ca. 2d oft bds., LK, Kauen + Kopfbeweg. Sz-haft, Fieber                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Inspektion + Palpation Hals</b><br/>(teigig-ödemat. Schwellung Regio parotidea)<br/><b>Lymphknoten</b><br/><b>Mund + Rachen (Rötung, Tonsillitis)</b><br/><b>Ohren</b><br/><b>Nase</b><br/><b>Ev. Internist. Status (Lunge)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Symptomatisch: NSAID, Fiebersenker</b></p> <p>Bis 9d nach Symptomen keine Gemeinschaftseinrichtungen besuchen!</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Paramyxovirus parotidis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Missbildungen am Hals</b>     | <p>Meist indolente Schwellung lat. od. median am Hals, angeboren, oft erst symptomatisch bei Infekten</p> <p><u>Laryngozele</u>: Globusgefühl, Dysphagie, Heiserkeit, Halsschwellung, Blasinstrumentenspieler, Pressen bewirkt Vorwölbung</p>                                                                                                                       | <p><b>Inspektion + Palpation Hals</b><br/><b>Lymphknoten</b><br/><b>Mund + Rachen</b><br/>Ev. Ohren, Nase<br/>Ev. Internist. Status (Lunge)</p>                                                                                           | <p>Keine Biopsie! US, ev. CT</p> <p>Bei Laryngozele: Laryngoskopie</p>                                                                                                                                                                | <p><u>Lat. + med. Halszyste</u>: <b>Exzision</b> (Inzision/Drainage löst Problem nicht &gt;Rezidive)</p> <p><u>Lat. + med. Fisteln</u>: müssen <b>verschlossen</b> werden</p> <p><u>Laryngozele</u>: <b>Ops</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Laterale Halszyste/Fistel</b>: wird oft bei Infektion symptomatisch (schwillt an)<br/><b>Mediane Halszyste/Fistel</b>: prall-elast., folgt Bew. d. Zungenbeins beim Schlucken, wird oft bei Infekten symptomatisch, muss gesamtes hyoid entfernen sonst Rezidiv<br/><b>Laryngozele</b>: innere (n. sichtbar v. aussen) + äussere Form,</p> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schilddrüsenpathologien | Hyper- + Hypothyreose-Symptome abfragen, Systemanamnese, B-Symptome, Sz.,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inspektion + Palpation Hals<br>„SD, Schlucktest<br>Lymphknoten<br>Lyngoskopie                                   | BE (AK, SD-Hormone, CRP), US, Szintigraphie, FNP<br><br>Keine Biopsie!                                          | Je nach Ursache                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DD: Struma (Iodmangel u.a.), Autonomie/Knoten, Entzündungen/autoimmun (Hashimoto, M. Basedow, Th. de Quervain), Neoplastisch (follikuläres + papilläres Adenom od. Karzinom, Anaplast. od. medull. Ca) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Madelung Fetthals       | Männer zw. 40-50 J., oft bei alk. Hepatopathie od. DM,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Inspektion + Palpation Hals<br>Lymphknoten<br>Mund + Rachen<br>Ev. Ohren, Nase<br>Ev. Internist. Status (Lunge) | Keine Biopsie! FNP<br><br>Therapie<br>Chirurgische Resektion<br><br>Gutartig, häufig Rezidive!                  | Weitere gutartige Tumoren<br>Lipom (DD Liposarkom), Neurinom/Schwannom (ev. Nervendysfunktion), Glomus-Caroticum-Tumor (BD-Abfälle bei Halsbewegungen, pulsierender Tumor, vor Resektion Bildgebung, ev. Angio/Embolisation), Hämangiom (oft angeboren od. seit klein, rötlich-weich, oft Spontanheilung, sonst B-Blocker/Embolisation/Laser/Resektion) >meist symptomlose Schwellung >Resektion |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Metastasen              | meist >60, meist solitäre indolente harte LK-Schwellung, oft bei Raucher + Alk, Primärtumor/PE-Ca meist im HNO-Bereich >suchen, B-Symptome                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Inspektion + Palpation Hals<br>Lymphknoten<br>Mund + Rachen<br>Ohren<br>Nase<br>Ev. Internist. Status (Lunge)   | FNP, PET-CT (Staging, suche Primärtumor!), ev. Panendoskopie mit Biopsien<br><br>Keine Biopsie d. Metastase/LK! | Je nach Stadium + Tumor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DD: Lymphom (solitärer LK od. generalisiert, RT-Chemo reicht, FNP + bei Verdacht Exzision ganzer LK um Typisierung zu machen)                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Speicheldrüsen          | Sialolithiasis: Postbrandiale Schwellung + danach Besserung, Kollik, ev. Eiter, M>F, in 80% Submandibularis<br>Sialadenitis: Sz., Schwellung, meist Submandibularis<br>Sialadenose: Schwellung, Xerostomie, Xerophthalmie, keine E., oft metabolische Probleme (DM, SD, Unterernährung, Nierenproblem) od. Medis<br>Sjögren-Sy: Schwellung Parotis, Xerostomie, Sicca-Sy/Xerophthalmie >Keratokonjunktivis<br>Pleomorphes Adenom: Schwellung/RF, meist indolent, selten Fazialisparese<br>Warthin Tumor/Zystadenolymphom: Schwellung/RF, meist indolent, selten Fazialisparese<br>Zysten<br>Mukoepidermoid-Ca, Adenoid-zystisches-Ca, PE-Ca:<br><br>*Pleomorphes Adenom: i.d.R. lat. Parotidektomie (Fazialisserhaltung, keine Enukleation weil Pseudopodien >Rezidive!) |                                                                                                                 |                                                                                                                 | Sialolithiasis: US, Rx (Stein), CT, Sialendoskopie<br>Sialadenitis: US (Ausschluss Sialolithiasis), BE (Serologien: Mumps, CMV, etc.), ev. Sialendoskopie<br>Sialadenose: keine Biopsie, ev. S-Endoskopie, US<br>Sjögren-Sy: Sialometrie, Schirmertest, BE (Rheumaf.), Unterlippen-Biopsie<br>Tumoren: US, FNP (keine Biopsie!), CT/MRI                                                          |                                                                                                                                                                                                        | Therapie<br>Sialolithiasis: Sialogoga (Chätschi, Zitronie >Speichelprod.↗), Sialendoskopie, Transorale Gangschlitzung, Lithotripsie (Zertrümmerung, prakt. nie), Submandibulärektomie (falls Rezidive)<br>Tumoren*: falls in FNP maligner Prozess >Chirurgie >itraop.<br>Schnellschnitt >falls benigne lat. PE, falls maligne totale PE + Neckdissection, ev. postop-RT |